

DE-RISKED ORPHAN COMMERCIALIZATION CASE

仲恩生醫（7729）Stemchymal 完整投資研究

日本 label、年度重複療程、產能與全球授權的估值重建

四項核心條件：若依公司端確認成立，價值已由『等待核准』切換為『驗證商轉速度』

本報告估計目前條件式合理價 NT\$150–180（中樞 165）、2027 年底 NT\$220–290（中樞 250）、2028 年底 NT\$340–460（中樞 400）。最大剩餘風險不再是 CMC 或 SARA≥11 可否被接受，而是 3,000 劑能否按期成為可放行、可出貨且能轉成付費療程的產能。

四大核心真正改變了什麼？

核心變數	核心前提	估值影響
日本目標 label	SCA3+SCA6、SARA≥11、每月一次共三劑	適用族群與療程從估計變成情境前提；監管折價大幅下降。
再次治療	完成三劑後可由醫師判斷再次接受療程	病患每年接受治療，可謂公司提供年度性收入；終值上修。
價格與分潤	終端每劑 NT\$100 萬；日本扣成本後約 50% 歸仲恩	日本由 REPROCELL 銷售，仲恩分潤模式。日本每位病患對於仲恩實質收入每年約 NT\$151 萬；
產能	初期 900 劑已可由台灣供應；預計 2027 年底藉由 Cyto-facto 擴大為 3,000 劑製程。	2028 年最多約 1,000 名病患三劑療程(3000 劑)；短期估值上限由產能決定。初期藥劑為供不應求。

FULLY DILUTED • 89.6M SHARES

估值快照

時點	合理區間	中樞	必要條件
目前	NT\$150–180	NT\$165	資訊可信，尚未全數公告；PMDA／台灣取證與價格尚未正式落地。
2027 年	NT\$220–290	NT\$250	台日取證、定價與早期商轉；至少一項區域授權(東南亞，歐洲，美國)進入簽約。
2028 年	NT\$340–460	NT\$400	800–1,000 個付費療程、全球授權選擇權升值。

重要證據聲明 | 本報告同時使用三層資料：

- A. 公開可驗證資料；
- B. 公司端確認事項但尚未全部出現在公開公告或監管文件中，所有估值均屬條件式核保，不代表已成為市場共同資訊。
- C. 由過往日本罕病市場相似之細胞治療反推假設。

1 | 證據層級與事件

事項	證據層級	本報告處理方式
日本正式送件	公開確認	2026/6/24，SCA3+SCA6；台灣仲恩製造、日本 REPROCELL 銷售。[1]
九個月審查	公開確認	受理後優先審查目標。
MHLW 外國製造業者認定	公開確認	降低台灣供應日本的資格風險。[2]
SARA≥11+三劑 label	公司端確認	依公司轉述，15 個月 pre-NDA 期間反覆確認
醫師可決定再次治療	公司端確認	解除一次性療程的終值限制；給付實務與真實世界持續性仍待上市驗證。
Cyto-Facto／Terumo	公開確認合作； 數量屬公司端規劃	前者承接 CDMO 開發製造，後者開發規模化智慧細胞擴增流程。[7][8]
美國 25 人／10 月收案	公司端更新	公開資料仍為 20 人、尚未收案；需等登錄更新或首位病患公告。[5][6]
AOP、東南亞洽談	公司端更新／尚未簽約	AOP 與細胞療法及罕病商業化高度匹配，但較像歐洲／中東夥伴。[11]

2026Q3–2028：價值應按順序釋放

時間	事件	投資判讀
2026Q3–Q4	IPO 申請；美國 II 期首位病患；台灣審查推進	確認治理、股本與美國試驗是否真正按照進度進行。
2026Q4–2027Q1	上市增資；台灣／日本可能取得藥證	確認年度性治療、上市後條件與病人端銷售價格。
2027H1	日台價格與付費路徑；美國完成收案的目標窗	首次把需求轉為療程與營收，公司研發成功變現，財務狀況改善。
2027H2	首批商業治療、東南亞授權、Cyto-Facto 3,000 劑驗證	合理價由事件型上修至商業化型；產能成為核心 KPI。
2028	800–1,000 人療程、日台真實世界數據(RWD)、歐洲／美國合作窗口	若再治療與療效持續性成立，可開始看 2029–2030 EPS。

註記 | REPROCELL 所稱九個月為『自受理起的目標審查期間』。在本報告假設 CMC、資料信賴性與目標族群均無重大爭議下，估日本於 2027Q1 前落地機率 75–85%，於 2027H1 前落地機率 92–96%。

2 | 臨床與監管：風險已轉移，而非消失

公開臨床事實沒有改變：日本隨機、雙盲、安慰劑對照 II 期在整體族群主要終點未達顯著，但基線 SARA $\geq$ 11 次族群出現方向一致且達顯著的訊號；台灣試驗亦呈現相同 severity-dependent pattern。[3] 本次更新改變的是監管判斷：依公司端確認，PMDA 已在 pre-NDA 互動中接受以 SARA $\geq$ 11 作為實際治療族群。

面向	採用前提／證據	估值意義
族群／基因型	SCA3+SCA6、SARA $\geq$ 11	與最有療效訊號的族群對齊；縮小治療範圍但提升 benefit-risk 可信度。
給藥	每月一次，共三劑靜脈輸注	與台日試驗暴露一致；不需為上市重新制定療程。
再次治療	完成三劑後由醫師判斷，可再次接受療程	允許年度型收入；但每年固定三劑的實際頻率仍要由醫師驗證。
安全性	完成跨國多中心兩組二期試驗，迄今無明確相關嚴重不良事件訊號	有利附條件／期限付核准及上市後擴大使用，但需長期藥物警戒。

更新後的 PMDA 事件機率

研究機率	分支事件	可能結果	估值影響
80%	如期取得預期 label	SCA3+SCA6、SARA $\geq$ 11、三劑；再次治療由醫師判斷。	完整基準估值。
15%	核准但延後／上市後條件較重	審查超過九個月、中心／登錄／追蹤要求更嚴。	價值延後 10–20%，不等同失敗。
5%	重大意外	資料信賴性、查廠、法規解讀或其他非預期問題。	回到現金與早期管線價值。

台灣 T-RMAT

TFDA 公開說明，T-RMAT 以高密度雙向溝通輔導整合衛服部(TFDA)和食藥署(CDE)專業；經確認的輔導結論可作為後續申請的依據，以加速再生醫療雙法執行落實。[4] 因此公司端所稱台日同步具有制度基礎，但本報告仍將 2026Q4–2027Q1 視為目標窗，而非公開確認的核准日。

剩餘監管風險 | 監管者即使接受再次治療，仍可能透過適用醫師、合格中心、登錄追蹤、基線重複評分及上市後試驗控制使用。

3 | 患者需求可能大於 2028 供給

本報告框架：不把日本約 3–3.7 萬名廣義 SCD 全部當市場，而以 SCA3／SCA6、SARA $\geq$ 11、確診、可到中心且願意治療者逐層縮減。年度再次治療成立後，peak active patients 的意義也由『累積曾治療』改為『每年可能回流的療程池』。

漏斗	研究估計人數	解讀
可辨識 SCA3+SCA6	日台合計約 6,350	長期疾病池，不是年度可治療人數。
符合 SARA $\geq$ 11	約 1,600–2,200	依嚴重度分布推估；範圍較寬。
launch-ready backlog	約 930–1,330	日本 700–1,000、台灣 150–250、台灣國際病患約 80。
2027 付費療程	200–300	受定價時間、中心啟動與 900 劑供給限制。
2028 付費療程	800–1,000	若 3,000 劑可放行，需求有機會快速填滿供給。
成熟 active pool	2,500–3,000	中央情境；5,500 人以上仍列 Bull，不作預測。

4 | 產能、價格與單位經濟

時間	劑數	三劑療程	狀態／必要條件
2027	900 劑	約 300 療程	台灣細胞工廠供應；足以支援早期 launch。
2027 年底目標	3,000 劑	約 1,000 療程	Cyto-Facto 計畫；唯一尚待時間驗證的核心假設。
2028	3,000 劑可出貨	800–1,000 療程	需驗證批次放行、良率、排程、跨境冷鏈與中心消化。
2029	4,500–6,000 劑	1,500–2,000 療程	分析推估；需 Cyto-Facto 擴張與 Terumo 製程移轉。
2030	7,500–9,000 劑	2,500–3,000 療程	成熟中央情境；Terumo 為 3,000 劑以上的規模化選項。

5 | 以現有 rNPV 做估計 NT150-180

目前仍屬事件前估值，採 15%折現率的日台核心現金流、再以 90–95%商業化成功權重調整；

目前組成	股權價值	每股	方法／限制
日台 SCA 核心資產	NT\$110–135 億	NT\$120–150	以中央病患曲線、100 萬藥價、15%折現與期限後保守終值。
上市後淨現金	NT\$11–16 億	NT\$12–18	含已完成現增與假設上市募資，扣 2026–2027 現金消耗。
美國／歐洲／東南亞選擇權	NT\$14–27 億	NT\$16–30	按目前臨床與談判成熟度風險調整，不計 headline milestone 全額。
未公開資訊折價	(NT\$0–15 億)	0 至 (NT\$17)	療效、產能、RWE 與授權並非獨立；避免全部樂觀項目機械相加。
目前合理股權價值	NT\$135–162 億	NT\$150–180	中樞約 NT\$165；相對於目前股價約 NT\$71–72 現價具明顯折價。[14]

2027-2028 估價方法：

由**目前**情境下 rNPV 股價為基準加上下列 milestone 逐步達成而上調

milestone	預期估值中樞	註解
台日核准 + 預期 label 公開	上移至 NT\$160-220	核心法規風險正式對所有市場參與者去除。
價格 ≥ NT\$90 萬 + 再次治療可給付	再上移約 NT\$30-60	直接提高每位年度收入與終值。
3,000 劑完成商業放行驗證	再上移約 NT\$30-50	把理論產能轉為可銷售產能。
東南亞 / AOP 簽約	約 NT\$5-25 / 股	視前金、權利範圍、供貨與權利金而定。
美國 II 期成果 + 可能授權	約 NT\$40-90 / 股	是最大海外選擇權； 啟動收案本身只值少量上修。 但若是正式授權，對照過往歷史收購案，仲恩估值須再大幅上修。

目前、2027 年、2028 年三情境股價路徑

情境	發生機率權重	目前	2027 年底	2028 年底	主要條件
保守執行	15%	NT\$105-135	NT\$150-200	NT\$220-300	價格偏低、產能 / 中心較慢；藥證仍成功。
基準	60%	NT\$150-180	NT\$220-290	NT\$340-460	本次四項條件成立；2028 達 800-1,000 療程。 未計入海外可能授權
樂觀	25%	NT\$180-220	NT\$320-400	NT\$500-700	產能突破、醫療旅遊強、歐洲與美國均簽約。

6 | 若以 EPS 推估 2027-2030 財務路徑

基準模型不把授權前金混入經常性營收，先以日台商業化驗證產品本身。療程人次可由新病患與再次治療病患共同構成；2027 價格於取證後約六個月落地，因此淨利率保守估計且只計**部分年度**。

一旦藥證通過產能提升，獲利可同步快速提升。

年度	療程人次 / 中央	需求劑數	營收	稅後淨利	EPS
2027E	200-300 / 250	600-900	NT\$3.0-4.5 億	NT\$0.5-1.0 億	0.6-1.1
2028E	800-1,000 / 950	2,400-3,000	NT\$12.1-15.1 億	NT\$5.4-8.3 億	6.0-9.3
2029E	1,500-2,000 / 1,800	4,500-6,000	NT\$22.7-30.2 億	NT\$11.3-16.6 億	12.6-18.5
2030E	2,500-3,000 / 3,000	7,500-9,000	NT\$37.8-45.4 億	NT\$20.8-25.0 億	23.2-27.9

中央模型計算

日本由 REPROCELL 銷售，仲恩分潤模式。日本每位病患對於仲恩實質收入每年約 NT\$151 萬；

年度	公式	營收	淨利率	充分稀釋 EPS
2027	250 × NT\$151 萬	NT\$3.78 億	20%	EPS 0.8
2028	950 × NT\$151 萬	NT\$14.36 億	50%	EPS 8.0
2029	1,800 × NT\$151 萬	NT\$27.22 億	55%	EPS 16.7
2030	3,000 × NT\$151 萬	NT\$45.36 億	55%	EPS 27.8

EPS 估值驗證 2027–2030 合理股價

評價時點	核心參考 EPS	本益比	淨現金／既有選擇權	合理股價區間
2027 年底	2028E EPS 8–10	18–22×	+NT\$40–70	NT\$220–290 (中樞 250)
2028 年底	2029E EPS 14–21	18–22×	+NT\$50–80	NT\$340–460 (中樞 400)
2029 年底	2030E EPS 23–28	16–20×	+NT\$30–50	NT\$400–560 (中樞 480)
2030 年底	2031E EPS 26–32*	15–18×	+NT\$20–40	NT\$420–600 (中樞 500)

註：股價區間不是把 EPS 與倍數端點機械直乘，而是採中央獲利、成長階段與淨現金／既有海外選擇權後的研究區間。*2031E 為研究外推，假設年度再次治療穩定且 Terumo 支援 3,000 療程以上；大型美國授權或收購未納入。

2027 年底 | 為何是 NT\$220–290？ 若台日取得可商業化藥證、每劑價格接近 NT\$100 萬、完整三劑可給付，2027 已有 200–300 人付費，2028 年的 3,000 劑產能完成驗證，且東南亞或 AOP 至少簽下一案，市場將由 rNPV 切換至 2028–2029 年 forward EPS。以 2028E EPS 8–10 元、18–22 倍，加計淨現金與區域授權選擇權，合理價約 NT\$220–290，中樞 250 元。IPO 增發 9,000 張雖使股數由約 8,058 萬增至 8,958 萬股，但同步取得現金，淨稀釋佔 3–6%；9 月申請、12 月至翌年 1 月掛牌在程序上可行但偏緊。[12]

2028 年底 | 為何是 NT\$340–460？ 若 2028 實際完成 800–1,000 個付費療程，即同時驗證需求能轉成營收、三劑療程可由醫院執行，以及 3,000 劑產能可商業放行。屆時市場可用 2029E EPS 14–21 元、18–22 倍評價，再加美國、歐盟與東南亞權利，合理價約 NT\$340–460，中樞 400 元。與前一章節用 rNPV 估價相去不遠。

7 | 美國二期：海外最大價值選擇權

從啟動到授權的價值階梯

公司端最新說法為 2026 年 10 月啟動、25 人、包含 UCLA，並預期 5–6 個月完成收案；截至本報告日，公開登錄仍顯示 20 人、Not yet recruiting，且保留較舊的單中心描述。[5][6] 因此模型以『公司端進度』作情境、以『登錄更新／首位病患』作價值確認點。

里程碑	研究時程	機率	美國選擇權價值	判讀
登錄更新+首位病患	2026Q4	65-80%	美國權利 standalone 約 NT\$10-20／股	證明試驗真正 active；只屬 小幅去風險。
完成 25 人收案	2027H1-H2	45-60%	約 NT\$15-35／股	需公開站點與收案速度支 持；仍沒有受控療效讀值。
24 週受控結果療效 清楚	2027H2-2028	目前 30- 40%	約 NT\$40-90／股	最大再評價點；需預設統計 而非首批個案主觀反應。
美國授權簽約	二期療效清楚後 最合理情境	療效確認後 65-70%	對照歷史案例大幅上修	看 upfront、權利範圍、權 利金與供貨



神經退化疾病治療藥物的重要及市場機會

- 罕見疾病藥物市場潛力龐大，預計全球規模將在2030年達到3,358.4億美元。
- 由於研發費用高、生產規模有限且患者人數稀少，罕見疾病藥物通常價格較高，以彌補成本並實現利潤。



Annual price of \$370,000

Friedreich’s ataxia 亦是一種遺傳性神經退化疾病，屬於脊髓小腦性共濟失調（**spinocerebellar ataxias**）的一種，原因來自 FXN 基因（**frataxin**）中的 GAA三核苷酸重複擴增突變(100–1,000 個重複)。

病例數及治療市場: 美國約5,000人；全球約15,000人。

銷售狀況:

- 2023 年 2 月 Skyclarys 獲美國 FDA 批准，成為首款治療 Friedreich’s ataxia（FA）之藥物，而後 Reata 在 2023 年 7 月以約 73 億美元被 Biogen 收購，**同年銷售約5600萬美元(約151個病人)**。
- 截至2024年底，**Skyclarys的全球年銷售額達3.825億美元(約1,033個病人)**。其中，美國市場貢獻了3.011億美元，國際市場貢獻了8,140萬美元。
- 2025年第一季，Skyclarys的銷售額進一步成長至1.24億美元，較去年同期成長59%。



Skyclarys／Reata 交易錨點：可比，但不能直接照搬

比較項目	Skyclarys／Reata	Stemchymal 於假設時點	估值含義
交易時點	FDA 核准後約 5 個月，Biogen 以總額約 73 億美元 收購整家 Reata。[17]	日台已商業化、美國 II 期陽性但尚未取得 FDA 核准。	Stemchymal 仍低一個主要監管階段。
商業驗證	SKYCLARYS 2024／2025 全球營收 US\$382.5m／US\$520.5m；EV 約為後見營收 19×／14×。[18]	美國基準峰值銷售 US\$120–450m；年度再次治療未納入。	US\$7.3bn 屬核准後上緣，不是 II 期基準。
產品與執行	口服小分子、首個 FA 核准療法、全球商業權利集中。	跨國細胞治療與低製造成本具技術溢價，但有輸注、CMC、冷鏈及放大風險。	應同時給平台溢價與執行折價。
權利結構	收購整家公司及核心全球資產。	美國由仲恩主導；日本、韓國已有獨家夥伴。[19]	任何收購價都要檢查區域權利與終止／移轉條款。

美國授權與整體收購的合理交易區間

交易情境	成立條件	upfront／headline	rNPV／企業價值	股價上修幅度
美國授權 基準	日台 RWD 安全；美國 II 期療效清楚；FDA 同意下一步	upfront 1-2.5 億美元； 總額 8-18 億美元	仲恩 rNPV 4.5-10 億美元	NT\$163–363
美國授權 強勢	效果具臨床意義、可重複療程、競爭性 BD	upfront 2.5-4 億美元； 總額 15-30 億美元	仲恩 rNPV 9-18 億美元	NT\$326–653

參照過往案例：美國方面在二期試驗結果和彼時真實世界數據(RWD)相對條件下，估計基準授權總額為 8-18 億美元，強勢授權為 15-30 億美元。但 headline milestone 不是現金，必須依成功率與時間折現；授權 rNPV 也要扣除 REPROCELL／其他區域權利、稅負、後續試驗成本與新增稀釋。因此得出表中股價上修幅度參照數據。

若美國二期 24 週數據療效明確，且簽下美國夥伴，行情可能上看 **NT\$500-700**；但那屬於未來 Bull case，不在本次報告預估之基本情境。

資料來源與方法

[1] [REPROCELL 送件](#) • [2] [MHLW 認定](#) • [3] [日本 II 期](#) • [4] [T-RMAT](#) • [5] [美國試驗登錄](#) • [6] [美國 II 期規劃](#) • [7] [Cyto-Facto](#) • [8] [Terumo](#)
[9] [REPROCELL 權利](#) • [10] [友華布局](#) • [11] [AOP](#) • [12] [上櫃時程](#) • [13] [日本送件報導](#) • [14] [7729 行情](#) • [15] [友華持股 9.078%](#) • [16] [友華董事席位](#)
[17] [Biogen | Reata US\\$7.3bn 收購](#) • [18] [Biogen 2025 年報 | SKYCLARYS 營收](#) • [19] [REPROCELL | 各區域開發權利](#)

方法與限制 | 患者數、藥價、淨利率、機率與股價區間均為條件式分析，非公司財測；公司端確認事項來自投資人於 2026/7/22 的轉述，未由公開文件獨立驗證。估值以約 8,958 萬股、NT\$32.5／US\$估算，未含稅費與流動性折價。